

· 标准与讨论 ·

精神分裂症维持治疗中国专家共识(2024)

中华医学会精神医学分会精神分裂症协作组 中国神经科学学会精神病学
基础与临床分会精神分裂症临床研究联盟

通信作者:刘登堂,上海交通大学医学院附属精神卫生中心,上海 200030,
Email:erliu110@126.com

【摘要】 精神分裂症是一种慢性、致残性脑病,全病程治疗包括急性期、巩固期及维持期治疗,维持治疗有利于降低精神分裂症的复发及再住院风险,促进社会功能康复,从而提高患者的长期结局。本共识在指导委员会的指导下,经过 35 位精神科专家反复讨论及 Delphi 匿名调研,最终形成了 21 项针对精神分裂症维持治疗的共识意见,涉及药物选择、药物剂量、治疗时间、特殊症状处理、心理及社会干预等方面。共识制定过程中同时结合了循证证据,有助于规范和指导中国成年精神分裂症的维持治疗。

【关键词】 精神分裂症; 维持治疗; 专家共识

基金项目:国家自然科学基金(82371504,82171496)

Chinese experts consensus on maintenance treatment of schizophrenia(2024)

Chinese Society of Psychiatry, Schizophrenia Coordination Group, Chinese Society of Neuroscience & Psychiatry, Schizophrenia Clinical Research Alliance

Corresponding author: Liu Dengtang, Shanghai Mental Health Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200030, China, Email: erliu110@126.com

【Abstract】 Schizophrenia is a chronic and debilitating mental disorder that requires an entire course of treatment covering acute, consolidation, and maintenance treatment. Standardized maintenance treatment is beneficial for reducing the risk of relapse and rehospitalization, promoting social functioning recovery, and thus improving long-term outcomes. Under the guidance of the steering committee, this consensus was formed after repeated discussions by 35 psychiatric experts and anonymous Delphi surveys, resulting in 21 consensus opinions on maintenance treatment for schizophrenia, involving aspects such as drug selection, dosage optimization, treatment duration, management of specific symptoms, psychosocial interventions, etc. The consensus-making process also incorporated evidence-based medicine to help standardize and guide maintenance treatment for adults with schizophrenia in China.

【Key words】 Schizophrenia; Maintenance treatment; Expert consensus

Fund program: National Natural Science Foundation of China(82371504, 82171496)

精神分裂症是一种重性精神疾病,其病因与发病机制尚未完全阐明。生物-社会-心理因素在疾病的发生发展及结局预后中起到了重要作用。精神分裂症的临床症状复杂,具有易复发特点。该病

通常起病早,症状严重且持续,严重损害患者的职业功能及社会功能,带来严重的社会负担。我国精神分裂症及相关精神病性障碍的加权终生患病率达 0.7%^[1]。

DOI: 10.3760/cma.j.cn113661-20240123-00037

收稿日期 2024-01-23 本文编辑 常静

引用本文:中华医学会精神医学分会精神分裂症协作组,中国神经科学学会精神病学基础与临床分会精神分裂症临床研究联盟. 精神分裂症维持治疗中国专家共识(2024)[J]. 中华精神科杂志, 2024, 57(7): 397-406. DOI: 10.3760/cma.j.cn113661-20240123-00037.



除了疾病本身特征外,治疗不依从与社会心理因素的交互作用也是导致精神分裂症慢性化、高致残性、预后不良的重要因素。药物治疗不规范与中断是最常见问题,而生活事件与急性应激也对疾病复发起到促发作用。一项荟萃分析显示,相对于任何非精神分裂症对照组,精神分裂症患者的全因死亡率升高 152%,而抗精神病药的合理规范使用能起到显著的保护作用^[2]。越来越多的循证证据支持精神分裂症急性期后继续使用抗精神病药维持治疗可有效降低复发风险、减少再住院率和死亡率,同时可以持续改善精神症状,并促进功能恢复和生活质量的提高^[3-6]。然而,目前我国对精神分裂症维持治疗相关问题仍存在较大分歧。本共识集合了我国精神科领域相关专家意见,同时结合了循证证据,就生物、社会、心理三大因素对精神分裂症的维持治疗提出建议,旨在规范中国精神分裂症的维持治疗,为成年精神分裂症患者的急性期后治疗与管理提供指导,尤其希望可以提高基层精神科医生的临床治疗水平,改善精神分裂症患者的功能预后和生存质量。

一、共识形成过程

本共识由中华医学会精神医学分会精神分裂症协作组、中国神经科学学会精神病学基础与临床分会精神分裂症临床研究联盟发起,上海交通大学医学院附属精神卫生中心刘登堂教授牵头组织,专

家共识意见的形成采用改良 Delphi 法,通过多轮次匿名投票表决,以及反馈修改形成最终意见。本共识已在国际实践指南注册与透明化平台完成注册(注册号:PREPARE-2024CN148)。来自国内外的 5 名精神科医生组成指导委员会(含 1 名方法学专家),负责指导共识形成的全过程,并提名了参与匿名投票的专家组及参与共识成文的工作组。投票使用 Likert 五点法,分为“1-强烈反对,2-反对,3-中立,4-同意,5-强烈同意”,若持“强烈反对+反对”或“强烈同意+同意”态度的专家比例≥70%,则认为达成共识,形成专家推荐意见^[7-8]。除此之外,本共识使用澳大利亚乔安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute, JBI)有效性研究证据预分级系统(表 1)^[9]对相关临床证据进行质量等级评定。最终,共有 35 位来自全国各省市的专家参与匿名调研,平均年龄 50.7 岁,平均精神科从业年限 26.3 年,均为副高及以上职称。3 轮问卷回收率均为 100%。指导委员会、专家组及工作组成员均不存在与本共识相关的利益冲突。

首先,工作组以“schizophrenia OR psychosis OR psychotic”“antipsychotic OR anti-psychotic”“long-term OR maintenance OR maintain OR stable OR remitted OR remission OR continue OR discontinue OR cessation OR stop OR withdrawal OR duration”作为关键词,按照 PICO(P:研究对象,I:干

表 1 JBI 有效性研究证据预分级系统

证据等级	研究设计类型	具体描述
级别 1	RCT/实验性研究	1a: 多项 RCT 的系统评价 1b: 多项 RCT 及其他干预性研究的系统评价 1c: 单项 RCT 1d: 准 RCT
级别 2	类实验性研究	2a: 多项类实验性研究的系统评价 2b: 多项类实验性研究及其他低质量干预性研究的系统评价 2c: 单项前瞻性有对照组的类实验性研究 2d: 前后对照/回顾性对照的类实验性研究
级别 3	观察性-分析性研究	3a: 多项队列研究的系统评价 3b: 多项队列研究及其他低质量观察性研究的系统评价 3c: 单项有对照组的队列研究 3d: 单项病例对照研究 3e: 单项无对照组的观察性研究
级别 4	观察性-描述性研究	4a: 多项描述性研究的系统评价 4b: 单项横断面研究 4c: 病例系列研究 4d: 个案研究
级别 5	专家意见/基础研究	5a: 对专家意见的系统评价 5b: 专家共识 5c: 基础研究/单项专家意见

注:JBI 为乔安娜布里格斯研究所;RCT 为随机对照试验

预措施,C:对照措施,O:研究结局)原则组合后,在 Pubmed、Embase、知网与万方等国内外多个数据库进行系统文献检索与筛选,检索时间截至 2023 年 7 月。在循证证据基础上,指导委员会结合临床需求初步提炼出精神分裂症维持治疗阶段的五大临床问题,并在 2023 年中国精神分裂症高峰论坛专家研讨会上进行讨论,形成第一轮调研问卷,共包含 15 项、33 个子条目。根据第一轮反馈结果,有 18 个子条目达成共识,而 12 个子条目未达成共识,另有 3 个子条目为开放性问题。指导委员会成员经过讨论及进一步查阅文献后,删去了 1 个子条目,增加了 4 个子条目,修改了 5 个子条目的表述,形成第二轮调研问卷,共包含 7 项、10 个子条目。根据第二轮反馈结果,有 6 个子条目达成共识,而 3 个子条目未达成共识,1 个子条目为开放性问题。针对第 2 轮专家组对于开放问题的回答情况,设计并形成了第三轮问卷,共包含 1 项、1 个条目,并最终达成共识。共形成了 21 项推荐意见。图 1 为专家共识意见形成流程图。在形成专家共识正文的过程中,根据指导委员会成员的意见进行多次反馈修改及循证证据的补充检索。

二、精神分裂症维持治疗相关临床问题的专家建议

1. 精神分裂症维持治疗的药物选择

专家建议 1: 精神分裂症患者急性期治疗后需要接受抗精神病药维持治疗(专家共识度 100%)

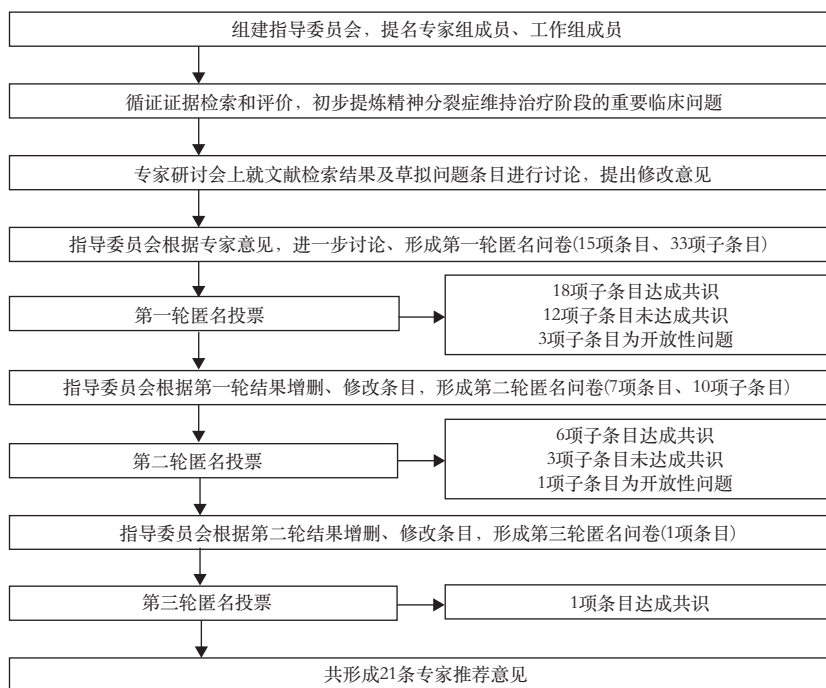


图 1 专家共识意见形成流程图

专家建议 2: 选择急性期治疗有效药物进行维持治疗(专家共识度 100%)

专家建议 3: 通常使用第 2 代抗精神病药维持治疗(专家共识度 97%)

精神分裂症接受抗精神病药维持治疗的主要目的是预防疾病复发。几项大样本荟萃分析发现,急性期后停药组(或安慰剂组)患者的复发率显著高于维持治疗组(证据级别:1a)^[3-5]。其中,2020 年 Cochrane 图书馆荟萃分析显示,上述结果在不同随访时段、不同治疗群体(如首次发作/复发)、不同药物种类及剂型、不同研究类型中均一致(证据级别:1a)^[5]。尽管有研究认为长期使用抗精神病药可能导致脑容量下降,但目前证据不足,尚不能得出统一结论^[10]。因此,有充足的循证医学证据支持精神分裂症患者急性期后应接受抗精神病药维持治疗。

对于抗精神病药的选择,几项大样本荟萃分析结果显示,目前常用的 30 余种口服及针剂药物相对于安慰剂均可显著降低疾病复发率,但未发现某种药物具有显著优势,药物间差异主要体现在不良反应(证据级别:1a)^[5, 11-12]。选择急性期治疗有效药物进行维持治疗是最为普遍的维持治疗选药策略。一项 2022 年的大样本荟萃分析发现,与停药相比,原药标准剂量维持治疗和换药维持治疗均可显著降低患者的复发率,并认为使用原药维持治疗是最佳的维持治疗策略(证据级别:1a)^[13]。

由于第 1 代抗精神病药较易产生锥体外系不良反应,导致患者难以耐受,临床上更倾向于使用第 2 代抗精神病药进行维持治疗。一项 2018 年的荟萃分析发现,第 1 代抗精神病药更易导致迟发性运动障碍,且不能归因于更高的药物剂量(证据级别:1a)^[14]。然而,第 2 代抗精神病药更易导致体重增加等代谢相关不良反应^[15],进而增加患者罹患心血管疾病和糖尿病等代谢性疾病的风险。综上,维持治疗阶段应重点考量药物不良反应,结合患者自身疾病风险和偏好,进行个体化的药物选择。长期治疗过程中,应定期随访心电图、血压、肝肾功能、血糖、体重、腰围及泌乳素等指标,对可能出现的不良反应进行宣教并及时干预。

专家建议 4: 维持治疗遵循抗精神病药单一治疗原则(专家共识度 80%)

专家建议 5: 如果患者疗效欠佳, 可以考虑两种抗精神病药联合治疗(专家共识度 89%)

精神分裂症维持治疗优先考虑单一抗精神病药。尽管联用两种抗精神病药在临床实践中较为常见, 考虑到其获益与风险的不确定性, 专家组未就此达成共识。较多专家提出, 出现“难以耐受的不良反应”或“单药疗效不佳”两种特殊情形时, 可以考虑联合使用两种抗精神病药。但在第 2 轮调研中, 专家仅就“单药疗效不佳”条目达成共识; 而对于“难以耐受的不良反应”, 相较于在降低原药物剂量的基础上合并用药, 更多专家推荐直接换用另一种抗精神病药。此外, 有较高比例的专家反对联用 3 种及以上抗精神病药, 认为该决策在增加不良反应的同时不能取得显著疗效。有系统综述显示, 多药联合维持治疗在减轻总体症状上优于单药治疗, 然而亚组分析显示这一优势仅存在于开放标签和低质量 RCT 研究中(证据级别: 1a)^[16]。目前有关抗精神病药联合维持治疗的循证证据主要来自观察性研究, 但在复发风险和不良反应等主要结局指标上结果并不一致^[17-19]。因此, 目前抗精神病药联合维持治疗的疗效和安全性尚未确定。

专家建议 6: 抗精神病药长效针剂(long-acting injectable antipsychotics, LAIs)有利于提高患者服药依从性, 降低复发率及再住院率(专家共识度 94%)

LAIs 能够有效提高精神分裂症患者的治疗依从性。有系统综述显示, LAIs 相较于口服抗精神病药(oral antipsychotics, OAPs)在预防复发及再住院方面优势更为显著(证据级别: 1a)^[20]。此外, 在促进临床症状缓解、改善社会功能和生活质量、减少不良反应及降低死亡风险方面, LAIs 也展示出不亚于 OAPs 的临床效益。在实际临床情境中, LAIs 可能因更佳的治疗依从性和连续性而带来更多益处^[21]。

通常, 治疗依从性差或患者个体偏好为启用 LAIs 的指征, 但近些年亦有观点认为, 可以尽早对首次发作患者和处于病程早期的患者启用 LAIs。现有研究对于早期启用 LAIs 的临床获益结果尚不一致^[22-23], 仍需要更多循证证据明确。

2. 精神分裂症维持治疗的药物剂量

专家建议 7: 抗精神病药维持治疗剂量通常不低于最低目标剂量, 但临床实践中也存在个体差异(专家共识度 89%)

研究表明, 精神分裂症急性期后减量维持治疗

复发风险更高、总体药物耐受性更差^[24-25]。抗精神病药剂量国际共识研究(International Consensus Study of Antipsychotic Dosing, ICSAD)以专家共识的方式形成了常见抗精神病药急性期治疗剂量推荐^[26]。Højlund 等^[27]以 ICSAD 中推荐的急性期目标剂量下限(lower limit, LL)作为维持治疗的标准剂量, 比较了维持期标准剂量治疗、较低剂量治疗(0.5~1.0 LL)和极低剂量治疗(<0.5 LL)3 种用药方案下的结局差异, 发现与标准剂量治疗组相比, 较低剂量、极低剂量组复发风险均显著升高, 但两种低剂量方案间无显著差异, 提示抗精神病药维持治疗的剂量不应过多地低于急性期治疗的标准剂量范围下限(证据级别: 1a)。ICSAD 中常见抗精神病药的 LL 如下^[26]: 氯丙嗪 300 mg/d, 奋乃静 12 mg/d, 氟哌啶醇 5 mg/d, 利培酮 4 mg/d, 奥氮平 10 mg/d, 阿立哌唑 15 mg/d, 喹硫平 400 mg/d, 氨磺必利 400 mg/d, 氯氮平 200 mg/d。ICSAD-2 对部分药物进行了推荐剂量的更新, 其中氟哌啶醇 4.5 mg/d, 利培酮 3 mg/d, 阿立哌唑 10 mg/d, 喹硫平 300 mg/d^[28]。抗精神病药的剂量-再复发风险曲线一般呈 J 型或 U 型曲线。有研究发现, 对于首次发作和复发 1~2 次的患者, 多数常见药物的维持剂量处于 0.9~1.1 WHO 定义日剂量(defined daily dose, DDDs)范围时预防效果最佳(利培酮的最佳维持剂量为 0.6~0.9 DDDs, 与 ICSAD 推荐的 LL 基本一致); 而对于复发 3 次及以上患者, 1.4~1.6 DDDs 剂量范围预防效果最佳^[29-30]。需要指出的是, 最佳维持剂量因人而异, 临床实践中存在部分患者以更低剂量维持治疗也能获得满意疗效^[31-32], 此外, 年龄及共病情况也是影响维持治疗剂量的重要因素。因此, 个体化考虑不同患者的最低维持剂量也非常重要。

3. 精神分裂症维持治疗时间

专家建议 8: 首次发作精神分裂症达到临床痊愈后, 至少需要维持治疗 3 年(专家共识度 77%)

专家建议 9: 首次复发(第 2 次发作)患者维持治疗时间至少 5 年(专家共识度 77%)

专家建议 10: 多次发作(复发 2 次及以上)患者建议终身服药(专家共识度 91%)

现有研究表明, 精神分裂症患者存在一定的异质性, 16%~30% 患者停药后可不出现疾病复发^[33-34]。然而, 由于目前尚无可靠方法判断哪些患者适合尝试停药, 美国精神病学协会指南、英国国家医疗卫生与社会服务优选研究所精神障碍系列指南等均推荐患者长期服药。然而, 大量患者在临

床实际诊疗过程中要求或自行减药或停药,因此提出可供临床医生参考的规范化维持治疗时长十分必要。

第一轮调研中,专家组对于首次发作患者的不同维持治疗时长(半年、1年、2年、3年或5年)均未达成共识;第二轮调研中,该问题修改为开放式,要求专家填写首次发作精神分裂症患者所需最短维持治疗时间,结果为偏态分布,中位数为3年;第三轮调研中,所有专家对首次发作精神分裂症至少需要维持治疗3年进行匿名投票,并达成共识。缺乏可靠的高级别循证证据是该问题较难形成共识的主要原因。目前尚无高质量荟萃分析或系统综述对不同维持治疗时长进行直接比较。在停药相关RCT研究中,不同研究设置的终点差异很大,也难以横向比较不同维持时长停药后复发风险^[6, 34-37]。总体上,绝大部分研究以首次发作精神病/首次发作精神分裂症为研究对象,且将急性期后病情稳定且维持治疗1年作为最基本时长,发现1年后继续维持治疗对复发的预防作用优于停药。其中,一项香港首次发作精神病RCT研究队列10年长期随访发现,停药组患者的长期不良结局更高(39%比21%),提示维持治疗至少2年(平均3年)的远期疗效优于1年(平均2年)^[34](证据级别:1c)。因此,首次发作精神分裂症患者临床痊愈后至少维持治疗3年具备一定的循证依据,但仍需更多研究对此进行探索。

复发是精神分裂症的常见现象。对英国精神病 AESOP-10 (Aetiology and Ethnicity in Schizophrenia and Other Psychoses)队列的10年随访研究提示,12.5%的患者仅有1次发作,23.2%患者症状持续未缓解,而64.3%患者会经历复发^[38]。多项荟萃分析、系统综述及RCT研究表明,既往复发次数较少的患者,此后复发风险也较低,且复发患者更能从维持治疗中获益(证据级别:2a)^[39-41]。因此,复发患者接受维持治疗的时长应比首次发作患者更长,但具体时长较难明确,主要原因是目前相关研究较少,证据严重不足。

4. 特殊症状处理(阴性症状、认知缺陷症状、抑郁症状及强迫症状)

专家建议 11: 可以选用某些第2代抗精神病药(如氨磺必利、阿立哌唑等)治疗精神分裂症的阴性症状(专家共识度91%)

专家建议 12: 可以联合重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,

rTMS)治疗精神分裂症的阴性症状(专家共识度86%)

现有抗精神病药对于改善精神分裂症阴性症状的效果均不十分显著。对于有明显阴性症状的患者,可以选用某些第2代抗精神病药。其中,氨磺必利和阿立哌唑获得了较多专家的推荐。一项系统综述以奥氮平作为参照药物,发现仅氨磺必利、阿立哌唑、佐替平和帕利哌酮对阴性症状的改善作用不亚于奥氮平(证据级别:1a)^[42]。另一项RCT研究则比较了自急性期始分别使用氨磺必利、阿立哌唑、奥氮平治疗1年的疗效,发现3种药物对阴性症状均有较小的改善作用[与基线比较PANSS阴性量表得分变化分别为(-4.8±1.1)、(-2.3±1.4)、(-4.0±1.0)分],但彼此之间无优劣之分(证据级别:1c)^[43]。一些新型抗精神病药,如卡利拉嗪、罗鲁哌酮、匹莫范色林等,具有不同于传统抗精神病药的作用机制^[44-46],有望较好地改善精神分裂症的阴性症状,但仍需更大样本的临床研究进行验证。

尽管有部分指南推荐对优化抗精神病药治疗后阴性症状没有明显改善的患者联合抗抑郁药进行治疗^[47],但仍缺乏足够循证证据支持这一方案的有效性。本次调研中,专家们亦未对此达成一致意见。一项系统综述显示,仅米氮平和美金刚作为增效药物时能有效改善难治性精神分裂症患者的阴性症状,而N-甲基-D-天冬氨酸(N-methyl-D-aspartic acid, NMDA)受体共激动剂则与安慰剂无明显差异(证据级别:1a)^[48]。美金刚作为NMDA受体拮抗剂,具有其独特的药理学机制:在正常生理状态下,药物不影响谷氨酸传递,仅在突触间谷氨酸浓度病理性增高时,非竞争性抑制NMDA受体的功能^[49]。

在物理干预方面,专家们就尝试联合rTMS治疗阴性症状达成共识。有系统综述发现,靶点位于左侧背外侧前额叶皮质的20 Hz rTMS和10 Hz rTMS均能显著改善阴性症状(20 Hz:标准均值差=-0.45, 95%CI: -0.79~-0.12; 10 Hz:标准均值差=-0.43, 95%CI: -0.68~-0.18)(证据级别:1a)^[50]。但相关研究样本量均较小,技术参数异质性较大,仍待更进一步的研究明确。一项伞形综述(umbrella review)指出,疗程至少3周的靶向背外侧前额叶皮质的高频率、高强度rTMS干预可能是改善精神分裂症阴性症状的最佳rTMS技术方案^[51]。

专家建议 13: 可以联合认知矫正技术(cognitive remediation, CR)治疗精神分裂症的认

知缺陷症状(专家共识度 83%)

专家建议 14: 可以尝试联合 rTMS 治疗精神分裂症的认知缺陷症状(专家共识度 74%)

目前已有的抗精神病药对于精神分裂症相关认知障碍的改善效果有限。尚有多种涉及不同神经递质系统的促认知药物正在研发中。CR 是一种基于行为训练的干预措施,其形式和内容多样^[52]。已有较多证据显示 CR 可有效改善精神分裂症认知缺陷(证据级别:1a)^[53-54]。此外,rTMS 技术也被探索性地用于治疗精神分裂症认知障碍,但现有研究证据对于 rTMS 改善认知功能的结果之间存在不一致性,这可能与具体技术范式异质性、各研究关注的认知功能领域及使用的认知范式不同有关。受询专家对此亦持相对保守的态度,仅获得 74% 专家推荐(26% 中立,63% 同意,11% 强烈同意)。

一项系统综述显示,rTMS 对于精神分裂症相关认知障碍可能有微小的改善作用(标准均值差=0.25,95%CI:0.01~0.49),但纳入研究的样本量较小,对结果的解读仍需谨慎^[55]。有研究发现,rTMS 改善工作记忆、执行功能和语言功能的效果相对优于其他认知领域^[51]。然而,也有研究显示 rTMS 干预后精神分裂症患者在不同意工作记忆认知范式中的表现并不优于对照组^[56]。因此,仍需更多研究和实践检验 rTMS 改善精神分裂症认知缺陷的有效性。

专家建议 15: 如果精神分裂症患者存在明显抑郁症状,而抑郁继发于幻觉妄想等精神病性症状或抗精神病药不良反应,建议调整现有抗精神病药治疗方案(专家共识度 94%)

专家建议 16: 如果精神分裂症的抑郁症状为中度-重度抑郁,建议联合抗抑郁药治疗和(或)心理治疗(专家共识度 97%)

专家建议 17: 如果精神分裂症患者伴有重度抑郁,且存在消极言行,建议住院治疗,联合抗抑郁药和(或)改良电休克疗法(modified electroconvulsive therapy, MECT)治疗为主(专家共识度 89%)

抑郁障碍是精神分裂症的常见共病,与患者不良预后、低生活质量及自杀风险相关;约 1/5 精神分裂症患者存在显著抑郁症状^[57]。抑郁症状可能来自于精神分裂症症状,也可能由抗精神病药副作用导致,在这些情况下,可以考虑调整药物治疗方案^[58]。对于同时符合抑郁障碍诊断标准的精神分裂症患者,联合使用抗抑郁药在改善抑郁症状及阴

性症状方面有微弱优势(证据级别:1a)^[59],并可降低其全因死亡率(证据级别:2c)^[60]。认知行为疗法等心理治疗方法对于改善精神分裂症患者抑郁症状也有潜在帮助(证据级别:1a)^[61]。近年来,MECT 也常被用于精神分裂症伴发重度抑郁的治疗^[59, 62](证据级别:1b)。

专家建议 18: 如果精神分裂症患者存在明显强迫症状,则首先审视强迫症状与精神病性症状及抗精神病药关系,调整抗精神病药治疗方案(专家共识度 97%)

专家建议 19: 联合 SSRI 类抗抑郁药治疗精神分裂症的强迫症状(专家共识度 97%)

精神分裂症患者共病强迫障碍的情况并不罕见。有系统综述显示,约 10.5% 尚未接受药物治疗的首次发作精神分裂症患者同时患有强迫障碍;约 34.0% 的首次发作精神分裂症患者出现了不满足强迫障碍诊断标准的强迫症状^[63]。氯氮平、利培酮和奥氮平等部分第 2 代抗精神病药与强迫症状的出现和加重有关。因此,我们建议,应首先考量强迫症状与疾病本身及抗精神病药治疗的关系,并考虑是否需要调整目前抗精神病药治疗方案^[64]。强迫症状的临床处理较为困难,如果调整或优化目前治疗方案并不能显著改善精神分裂症患者的强迫症状,可以考虑联合选择性 5-HT 再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs)治疗,35 名专家中,30 名(85.7%)专家推荐舍曲林,24 名(68.6%)专家推荐氟伏沙明。三环类抗抑郁药氯米帕明具有较好的抗强迫作用,但该药的不良反应发生率较高,容易发生药物相互作用,因此,专家们也不推荐使用氯米帕明治疗精神分裂症的强迫症状。

5. 心理治疗及社会干预治疗

专家建议 20: 抗精神病药维持治疗基础上联合心理治疗(如认知行为疗法及家庭治疗等)(专家共识度 91%)

在药物维持治疗的基础上联合心理治疗有助于改善精神分裂症阳性症状、认知功能、社会功能等多维度症状表现。一项系统综述显示,常规治疗辅以认知行为疗法有助于降低疾病复发率;接受常规治疗辅以社会认知互动训练的患者,阳性症状与阴性症状量表得分均更低、社会功能得分更高(证据级别:1a)^[65]。支持性心理治疗旨在从情绪支持、症状管理、自我知觉及日常生活能力改善等多方面辅助治疗精神分裂症;家庭治疗可以增强家庭内部的理解与支持,提高对疾病的认识,并以此改善患

者社会功能、降低疾病复发率(证据级别:1a)^[66]。本专家共识所询35名专家中,32名(91.4%)专家认为心理治疗对于辅助精神分裂症维持治疗有益。其中,31名(96.9%)专家推荐认知行为疗法,29名(82.9%)专家推荐支持性心理疗法,28名(80.0%)专家推荐家庭治疗。

专家建议 21:抗精神病药维持治疗基础上联合社会干预(如职业技能训练及社交技能训练等)(专家共识度 94%)

为提高患者生活质量,在控制疾病症状的同时,还需重视患者的社会功能、职业功能恢复情况。精神分裂症患者失业率显著高于普通人群,而失业或可进一步引起患者病耻感及抑郁情绪,对治疗产生不利影响。职业康复(vocational rehabilitation, VR)旨在帮助精神分裂症患者就业,患者在就业前接受短期职业培训,以为正式工作做好准备,有助于降低患者及其家庭疾病负担,帮助患者回归社会。家庭心理教育及针对患者的健康教育通过宣教,使患者及家属了解疾病、药物相关知识及复发预防措施,可有效降低疾病复发率及再住院率^[66](证据级别:1a),提高患者的社会及职业功能^[65](证据级别:1b)。社交技能训练旨在通过言语及非言语沟通技能训练,缓解患者的社交压力、助其发展社会关系。相比常规治疗,药物治疗辅以社交技能训练可以更好地改善患者的阴性症状^[65]、降低疾病复发率^[67](证据级别:1a)。

三、总结与展望

本共识围绕精神分裂症维持治疗相关临床问题展开,涵盖了药物选择、药物剂量、减药或停药、特殊症状处理以及非药物治疗等多个方面,对国内各级医疗机构(尤其基层医院)的精神科临床实践具有指导作用和参考价值。目前,部分临床问题(如精神分裂症维持治疗时长问题)尚存在较大争议,循证证据尚不充分,临床实践中也多有分歧,即使经过多轮函询,专家间尚不能达成完全一致,期待未来出现更多围绕这些问题开展的高质量临床研究。本共识也存在一些不足之处,如:专家组缺乏多学科团队参与,匿名调研结果存在学科局限性;另外,由于精神分裂症自身存在的异质性,共识未能形成更具有针对性和可操作性的临床决策推荐。本共识将在未来持续更新,以期最大限度地满足临床需求。

指导委员会:江开达(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、金华(美国加州大学圣地亚哥分校医学院)、

赵靖平(中南大学湘雅二医院精神病学科)、于欣(北京大学第六医院)、李春波(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)

专家组成员(以姓氏汉语拼音字母排序):程宇琪(昆明医科大学第一附属医院)、董芳(首都医科大学附属北京安定医院)、郭文斌(中南大学湘雅二医院精神病学科)、何红波(南方医科大学附属医院广东省人民医院)、胡少华(浙江大学医学院附属第一医院)、李冠军(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、李清伟(同济大学附属同济医院)、李毅(华中科技大学同济医学院附属精神卫生中心)、刘寰忠(安徽医科大学附属巢湖医院)、刘志芬(山西医科大学第一医院)、陆峥(同济大学附属同济医院)、马现仓(西安交通大学第一附属医院)、马小红(四川大学华西医院)、蒲城城(北京大学第六医院)、邵春红(复旦大学附属华山医院)、盛建华(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、石川(北京大学第六医院)、施慎逊(复旦大学附属华山医院)、司天梅(北京大学第六医院)、宋学勤(郑州大学第一附属医院)、谭云龙(北京回龙观医院)、王传跃(首都医科大学附属北京安定医院)、王化宁(空军军医大学西京医院)、王惠玲(武汉大学人民医院)、王继军(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、王强(四川大学华西医院)、吴仁容(中南大学湘雅二医院精神病学科)、夏炎(哈尔滨医科大学附属第一医院)、熊祖伦(合肥市第四人民医院)、杨甫德(北京回龙观医院)、姚志剑(南京医科大学附属脑科医院)、易正辉(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、郑英君(广州医科大学附属脑科医院)、朱刚(中国医科大学附属第一医院)、朱海兵(广州医科大学附属番禺中心医院)

工作组/执笔组成员:薛菁心(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、马相宜(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、赵宇晴(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、项琼(上海交通大学医学院附属精神卫生中心)、李春波、江开达、刘登堂

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] Huang Y, Wang Y, Wang H, et al. Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study[J]. Lancet Psychiatry, 2019, 6(3): 211-224. DOI: 10.1016/S2215-0366(18)30511-X.
- [2] Correll CU, Solmi M, Croatto G, et al. Mortality in people with schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of relative risk and aggravating or attenuating factors[J]. World Psychiatry, 2022, 21(2): 248-271. DOI: 10.1002/wps.20994.
- [3] Thompson A, Winsper C, Marwaha S, et al. Maintenance antipsychotic treatment versus discontinuation strategies following remission from first episode psychosis: systematic review[J]. BJPsych Open, 2018, 4(4): 215-225. DOI: 10.1192/bjo.2018.17.
- [4] Kishi T, Ikuta T, Matsui Y, et al. Effect of discontinuation v. maintenance of antipsychotic medication on relapse rates in patients with remitted/stable first-episode psychosis:

- a meta-analysis[J]. *Psychol Med*, 2019, 49(5): 772-779. DOI: 10.1017/S0033291718001393.
- [5] Ceraso A, Lin JJ, Schneider-Thoma J, et al. Maintenance treatment with antipsychotic drugs for schizophrenia[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2020, 8(8): CD008016. DOI: 10.1002/14651858.CD008016.pub3.
 - [6] Tiihonen J, Tanskanen A, Taipale H. 20-Year nationwide follow-up study on discontinuation of antipsychotic treatment in first-episode schizophrenia[J]. *Am J Psychiatry*, 2018, 175(8): 765-773. DOI: 10.1176/appi.ajp.2018.17091001.
 - [7] 中华医学会呼吸病学分会, 中国医师协会呼吸医师分会. 间质性肺疾病多学科讨论规范中国专家共识[J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2023, 46(12): 1176-1188. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20230726-00030
Chinese Thoracic Society, Chinese Medical Association, Chinese Association of Chest Physician, Chinese Medical Doctor Association., Chinese expert consensus on multidisciplinary discussion of interstitial lung disease[J]. *Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Diseases*, 2023, 46(12): 1176-1188. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20230726-00030.
 - [8] Hasson F, Keeney S, McKenna H. Research guidelines for the Delphi survey technique[J]. *J Adv Nurs*, 2000, 32(4): 1008-1015.
 - [9] 王春青, 胡雁. JBI 证据预分级及证据推荐级别系统 (2014 版)[J]. *护士进修杂志*, 2015, (11): 964-967.
 - [10] Goff DC, Falkai P, Fleischacker WW, et al. The long-term effects of antipsychotic medication on clinical course in schizophrenia[J]. *Am J Psychiatry*, 2017, 174(9): 840-849. DOI: 10.1176/appi.ajp.2017.16091016.
 - [11] Schneider-Thoma J, Chalkou K, Dörries C, et al. Comparative efficacy and tolerability of 32 oral and long-acting injectable antipsychotics for the maintenance treatment of adults with schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis[J]. *Lancet*, 2022, 399(10327): 824-836. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01997-8.
 - [12] Kishimoto T, Hagi K, Nitta M, et al. Long-term effectiveness of oral second-generation antipsychotics in patients with schizophrenia and related disorders: a systematic review and meta-analysis of direct head-to-head comparisons[J]. *World Psychiatry*, 2019, 18(2): 208-224. DOI: 10.1002/wps.20632.
 - [13] Ostuzzi G, Vita G, Bertolini F, et al. Continuing, reducing, switching, or stopping antipsychotics in individuals with schizophrenia-spectrum disorders who are clinically stable: a systematic review and network meta-analysis[J]. *Lancet Psychiatry*, 2022, 9(8): 614-624. DOI: 10.1016/S2215-0366(22)00158-4.
 - [14] Carbon M, Kane JM, Leucht S, et al. Tardive dyskinesia risk with first-and second-generation antipsychotics in comparative randomized controlled trials: a meta-analysis [J]. *World Psychiatry*, 2018, 17(3): 330-340. DOI: 10.1002/wps.20579.
 - [15] Zhang JP, Gallego JA, Robinson DG, et al. Efficacy and safety of individual second-generation vs. first-generation antipsychotics in first-episode psychosis: a systematic review and meta-analysis[J]. *Int J Neuropsychopharmacol*, 2013, 16(6): 1205-1218. DOI: 10.1017/S1461145712001277.
 - [16] Galling B, Roldán A, Hagi K, et al. Antipsychotic augmentation vs. monotherapy in schizophrenia: systematic review, meta-analysis and meta-regression analysis[J]. *World Psychiatry*, 2017, 16(1): 77-89. DOI: 10.1002/wps.20387.
 - [17] Lin CH, Huang CJ, Lin TC, et al. Schizophrenia patients discharged on antipsychotic polypharmacy from a public psychiatric hospital in Taiwan, 2006-2021[J]. *Psychiatry Res*, 2023, 330: 115575. DOI: 10.1016/j.psychres.2023.115575.
 - [18] Taipale H, Tanskanen A, Tiihonen J. Safety of antipsychotic polypharmacy versus monotherapy in a nationwide cohort of 61, 889 patients with schizophrenia [J]. *Am J Psychiatry*, 2023, 180(5): 377-385. DOI: 10.1176/appi.ajp.20220446.
 - [19] Tiihonen J, Taipale H, Mehtälä J, et al. Association of antipsychotic polypharmacy vs monotherapy with psychiatric rehospitalization among adults with schizophrenia[J]. *JAMA Psychiatry*, 2019, 76(5): 499-507. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2018.4320.
 - [20] Kishimoto T, Hagi K, Kurokawa S, et al. Long-acting injectable versus oral antipsychotics for the maintenance treatment of schizophrenia: a systematic review and comparative meta-analysis of randomised, cohort, and pre-post studies[J]. *Lancet Psychiatry*, 2021, 8(5): 387-404. DOI: 10.1016/S2215-0366(21)00039-0.
 - [21] Efthimiou O, Taipale H, Radua J, et al. Efficacy and effectiveness of antipsychotics in schizophrenia: network meta-analyses combining evidence from randomised controlled trials and real-world data[J]. *Lancet Psychiatry*, 2024, 11(2): 102-111. DOI: 10.1016/S2215-0366(23)00366-8.
 - [22] Wei Y, Yan V, Kang W, et al. Association of long-acting injectable antipsychotics and oral antipsychotics with disease relapse, health care use, and adverse events among people with schizophrenia[J]. *JAMA Netw Open*, 2022, 5(7): e2224163. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.24163.
 - [23] Winter-van Rossum I, Weiser M, Galderisi S, et al. Efficacy of oral versus long-acting antipsychotic treatment in patients with early-phase schizophrenia in Europe and Israel: a large-scale, open-label, randomised trial (EULAST) [J]. *Lancet Psychiatry*, 2023, 10(3): 197-208. DOI: 10.1016/S2215-0366(23)00005-6.
 - [24] Moncrieff J, Crellin N, Stansfeld J, et al. Antipsychotic dose reduction and discontinuation versus maintenance treatment in people with schizophrenia and other recurrent psychotic disorders in England (the RADAR trial): an open, parallel-group, randomised controlled trial [J]. *Lancet Psychiatry*, 2023, 10(11): 848-859. DOI: 10.1016/S2215-0366(23)00258-4.
 - [25] Rodolico A, Sifas S, Bighelli I, et al. Antipsychotic dose reduction compared to dose continuation for people with schizophrenia[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2022, 11(11): CD014384. DOI: 10.1002/14651858.CD014384.pub2.
 - [26] Gardner DM, Murphy AL, O'Donnell H, et al. International consensus study of antipsychotic dosing[J]. *Am J Psychiatry*, 2010, 167(6): 686-693. DOI: 10.1176/appi.ajp.2009.09060802.
 - [27] Højlund M, Kemp AF, Haddad PM, et al. Standard versus

- reduced dose of antipsychotics for relapse prevention in multi-episode schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials[J]. *Lancet Psychiatry*, 2021, 8(6): 471-486. DOI: 10.1016/S2215-0366(21)00078-X.
- [28] McAdam MK, Baldessarini RJ, Murphy AL, et al. Second international consensus study of antipsychotic dosing (ICSAD-2) [J]. *J Psychopharmacol*, 2023, 37(10):982-991. DOI: 10.1177/02698811231205688.
- [29] Taipale H, Tanskanen A, Correll CU, et al. Real-world effectiveness of antipsychotic doses for relapse prevention in patients with first-episode schizophrenia in Finland: a nationwide, register-based cohort study[J]. *Lancet Psychiatry*, 2022, 9(4): 271-279. DOI: 10.1016/S2215-0366(22)00015-3.
- [30] Taipale H, Tanskanen A, Luykx JJ, et al. Optimal doses of specific antipsychotics for relapse prevention in a nationwide cohort of patients with schizophrenia[J]. *Schizophr Bull*, 2022, 48(4): 774-784. DOI: 10.1093/schbul/sbac039.
- [31] Leucht S, Bauer S, Sifakis S, et al. Examination of dosing of antipsychotic drugs for relapse prevention in patients with stable schizophrenia: a Meta-analysis[J]. *JAMA Psychiatry*, 2021, 78(11): 1238-1248. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2021.2130.
- [32] Davis JM, Jin H. Choosing an optimal antipsychotic dose for relapse prevention[J]. *Schizophr Bull*, 2022, 48(4): 723-725. DOI: 10.1093/schbul/sbac045.
- [33] Wils RS, Gotfredsen DR, Hjorthøj C, et al. Antipsychotic medication and remission of psychotic symptoms 10 years after a first-episode psychosis[J]. *Schizophr Res*, 2017, 182:42-48. DOI: 10.1016/j.schres.2016.10.030.
- [34] Hui C, Honer WG, Lee E, et al. Long-term effects of discontinuation from antipsychotic maintenance following first-episode schizophrenia and related disorders: a 10 year follow-up of a randomised, double-blind trial[J]. *Lancet Psychiatry*, 2018, 5(5): 432-442. DOI: 10.1016/S2215-0366(18)30090-7.
- [35] Üçok A, Kara İA. Relapse rates following antipsychotic discontinuation in the maintenance phase after first-episode of schizophrenia: Results of a long-term follow-up study[J]. *Schizophr Res*, 2020, 225:31-38. DOI: 10.1016/j.schres.2019.10.015.
- [36] Wunderink L, Nieboer RM, Wiersma D, et al. Recovery in remitted first-episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance treatment strategy: long-term follow-up of a 2-year randomized clinical trial[J]. *JAMA Psychiatry*, 2013, 70(9): 913-920. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2013.19.
- [37] Mayoral-van Son J, de la Foz VO, Martinez-Garcia O, et al. Clinical outcome after antipsychotic treatment discontinuation in functionally recovered first-episode nonaffective psychosis individuals: a 3-year naturalistic follow-up study[J]. *J Clin Psychiatry*, 2016, 77(4):492-500. DOI: 10.4088/JCP.14m09540.
- [38] Morgan C, Lappin J, Heslin M, et al. Reappraising the long-term course and outcome of psychotic disorders: the AESOP-10 study[J]. *Psychol Med*, 2014, 44(13): 2713-2726. DOI: 10.1017/S0033291714000282.
- [39] Tani H, Suzuki T, Wolfgang Fleischhacker W, et al. Clinical characteristics of patients with schizophrenia who successfully discontinued antipsychotics: a literature review[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2018, 38(6):582-589. DOI: 10.1097/JCP.0000000000000959.
- [40] Leucht S, Tardy M, Komossa K, et al. Antipsychotic drugs versus placebo for relapse prevention in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis[J]. *Lancet*, 2012, 379(9831): 2063-2071. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60239-6.
- [41] Gaebel W, Jänner M, Frommann N, et al. First vs multiple episode schizophrenia: two-year outcome of intermittent and maintenance medication strategies[J]. *Schizophr Res*, 2002, 53(1-2): 145-159. DOI: 10.1016/S0920-9964(01)00182-7.
- [42] Leucht S, Schneider-Thoma J, Burschinski A, et al. Long-term efficacy of antipsychotic drugs in initially acutely ill adults with schizophrenia: systematic review and network meta-analysis[J]. *World Psychiatry*, 2023, 22(2):315-324. DOI: 10.1002/wps.21089.
- [43] Johnsen E, Kroken RA, Løberg EM, et al. Amisulpride, aripiprazole, and olanzapine in patients with schizophrenia-spectrum disorders (BeSt InTro): a pragmatic, rater-blind, semi-randomised trial[J]. *Lancet Psychiatry*, 2020, 7(11): 945-954. DOI: 10.1016/S2215-0366(20)30341-2.
- [44] Németh G, Laszlovszky I, Czobor P, et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial[J]. *Lancet*, 2017, 389(10074): 1103-1113. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30060-0.
- [45] Davidson M, Saoud J, Staner C, et al. Efficacy and safety of roluperidone for the treatment of negative symptoms of schizophrenia[J]. *Schizophr Bull*, 2022, 48(3): 609-619. DOI: 10.1093/schbul/sbac013.
- [46] Bugarski-Kirola D, Arango C, Fava M, et al. Pimavanserin for negative symptoms of schizophrenia: results from the ADVANCE phase 2 randomised, placebo-controlled trial in North America and Europe[J]. *Lancet Psychiatry*, 2022, 9(1):46-58. DOI: 10.1016/S2215-0366(21)00386-2.
- [47] Galderisi S, Kaiser S, Bitter I, et al. EPA guidance on treatment of negative symptoms in schizophrenia[J]. *Eur Psychiatry*, 2021, 64(1): e21. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2021.13.
- [48] Yeh TC, Correll CU, Yang FC, et al. Pharmacological and nonpharmacological augmentation treatments for clozapine-resistant schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis with normalized entropy assessment[J]. *Asian J Psychiatr*, 2023, 79: 103375. DOI: 10.1016/j.ajp.2022.103375.
- [49] Di Iorio G, Baroni G, Lorusso M, et al. Efficacy of memantine in schizophrenic patients: a systematic review [J]. *J Amino Acids*, 2017, 2017:7021071. DOI: 10.1155/2017/7021071.
- [50] Tseng PT, Zeng BS, Hung CM, et al. Assessment of noninvasive brain stimulation interventions for negative symptoms of schizophrenia: a systematic review and network Meta-analysis[J]. *JAMA Psychiatry*, 2022, 79(8): 770-779. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2022.1513.
- [51] Yi S, Wang Q, Wang W, et al. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on negative symptoms and cognitive functioning in schizophrenia: An

- umbrella review of systematic reviews and meta-analyses [J]. Psychiatry Res, 2024, 333: 115728. DOI: 10.1016/j.psychres.2024.115728.
- [52] Bowie CR, Bell MD, Fiszdon JM, et al. Cognitive remediation for schizophrenia: an expert working group white paper on core techniques[J]. Schizophr Res, 2020, 215:49-53. DOI: 10.1016/j.schres.2019.10.047.
- [53] Vita A, Barlati S, Ceraso A, et al. Effectiveness, core elements, and moderators of response of cognitive remediation for schizophrenia: a systematic review and Meta-analysis of randomized clinical trials[J]. JAMA Psychiatry, 2021, 78(8): 848-858. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2021.0620.
- [54] Lejeune JA, Northrop A, Kurtz MM. A Meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: efficacy and the role of participant and treatment factors[J]. Schizophr Bull, 2021, 47(4): 997-1006. DOI: 10.1093/schbul/sbab022.
- [55] Li X, Dai J, Liu Q, et al. Efficacy and safety of non-invasive brain stimulation on cognitive function for cognitive impairment associated with schizophrenia: a systematic review and meta-analysis[J]. J Psychiatr Res, 2024, 170: 174-186. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2023.12.003.
- [56] Sloan NP, Byrne LK, Enticott PG, et al. Non-invasive brain stimulation does not improve working memory in schizophrenia: a Meta-analysis of randomised controlled trials[J]. Neuropsychol Rev, 2021, 31(1): 115-138. DOI: 10.1007/s11065-020-09454-4.
- [57] B N S, Grover S. Depression in schizophrenia: prevalence and its impact on quality of life, disability, and functioning [J]. Asian J Psychiatry, 2020, 54: 102425. DOI: 10.1016/j.ajp.2020.102425.
- [58] Ceskova E. Pharmacological strategies for the management of comorbid depression and schizophrenia [J]. Expert Opin Pharmacother, 2020, 21(4):459-465. DOI: 10.1080/14656566.2020.1717466.
- [59] Helfer B, Samara MT, Huhn M, et al. Efficacy and safety of antidepressants added to antipsychotics for schizophrenia: a systematic review and Meta-analysis[J]. Am J Psychiatry, 2016, 173(9): 876-886. DOI: 10.1176/appi.ajp.2016.15081035.
- [60] Sher L, Kahn RS. Suicide in schizophrenia: an educational overview[J]. Medicina (Kaunas), 2019, 55(7): 361. DOI: 10.3390/medicina55070361.
- [61] Laws KR, Darlington N, Kondel TK, et al. Cognitive behavioural therapy for schizophrenia-outcomes for functioning, distress and quality of life: a meta-analysis[J]. BMC Psychol, 2018, 6(1): 32. DOI: 10.1186/s40359-018-0243-2.
- [62] Ali SA, Mathur N, Malhotra AK, et al. Electroconvulsive therapy and schizophrenia: a systematic review[J]. Mol Neuropsychiatry, 2019, 5(2): 75-83. DOI: 10.1159/000497376.
- [63] Martinho FP, Magalhães D, Felício R, et al. Obsessive-compulsive symptoms in first episode psychosis and risk states: systematic review with meta-analysis[J]. Schizophr Res, 2023, 255: 41-51. DOI: 10.1016/j.schres.2023.03.024.
- [64] Sharma LP, Reddy Y. Obsessive-compulsive disorder comorbid with schizophrenia and bipolar disorder[J]. Indian J Psychiatry, 2019, 61(Suppl 1): S140-S148. DOI: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_527_18.
- [65] Bighelli I, Salanti G, Huhn M, et al. Psychological interventions to reduce positive symptoms in schizophrenia: systematic review and network meta-analysis[J]. World Psychiatry, 2018, 17(3):316-329. DOI: 10.1002/wps.20577.
- [66] Solmi M, Croatto G, Piva G, et al. Efficacy and acceptability of psychosocial interventions in schizophrenia: systematic overview and quality appraisal of the meta-analytic evidence[J]. Mol Psychiatry, 2023, 28(1): 354-368. DOI: 10.1038/s41380-022-01727-z.
- [67] Turner DT, McGlanaghy E, Cuijpers P, et al. A Meta-analysis of social skills training and related interventions for psychosis[J]. Schizophr Bull, 2018, 44(3): 475-491. DOI: 10.1093/schbul/sbx146.



欢迎关注本刊官方微信公众平台

《中华精神科杂志》微信公众平台已正式开通,广大读者可通过扫描本简讯左上角的二维码或通过微信平台搜索公众号“中华精神科杂志”关注本刊。本刊微信平台的内容目前分为“期刊频道(当前期刊、往期期刊、期刊预告、期刊检索)”“微活动(指南解读、微会议、微病例)”“会员服务(现场互动、意见反馈、会员注册、关于我们)”3个版块,今后除杂志的官方网站(www.cjop.org.cn)以外,我们将通过微信平台中的期刊频道同步更新每期杂志的内容摘要,使读者了解最新的杂志动态。另外,自2017年10月起,“指南解读”一项中已呈现多位专家针对指南各部分内容进行的精彩解读,欢迎广大读者访问并提出宝贵的意见和建议。

·读者·作者·编者·